أسئلة MCQ — تصوير الحوض

التصوير الشعاعي · نظري · 30 سؤال · الجواب الصحيح معلّم بـ ✓

1.

What is the minimum SID for pelvis radiography?

ما أقل مسافة بين المصدر ومستقبِل الصورة SID في تصوير الحوض؟

A) 72 inches (183 cm)

72 إنش (183 سم)

B) 30 inches (76 cm)

30 إنش (76 سم)

C) 40 inches (102 cm) ✓ الجواب الصحيح

40 إنش (102 سم)

D) 60 inches (152 cm)

60 إنش (152 سم)

💡 المحاضرة: أقل SID هو 40 إنش (102 سم).

2.

Which IR size and placement are used for the pelvis?

ما حجم مستقبِل الصورة ووضعه في تصوير الحوض؟

A) 24 × 30 cm, crosswise

24 × 30 سم، بالعرض

B) 35 × 43 cm, lengthwise ✓ الجواب الصحيح

35 × 43 سم، بالطول

C) 18 × 24 cm, lengthwise

18 × 24 سم، بالطول

D) 35 × 35 cm, crosswise

35 × 35 سم، بالعرض

💡 عوامل التعرّض: IR بحجم 35 × 43 سم (14 × 17 إنش) بالطول.

3.

What kVp range is given for the pelvis?

ما مدى kVp المذكور لتصوير الحوض؟

A) 50-60 kVp

kVp 60–50

B) 70-80 kVp ✓ الجواب الصحيح

kVp 80–70

C) 100-120 kVp

kVp 120–100

D) 40-50 kVp

kVp 50–40

💡 عوامل التعرّض في المحاضرة: 70–80 kVp و20–30 mAs.

4.

What should the patient do with breathing during the pelvis exposure?

ماذا يفعل المريض بالتنفّس أثناء تعرّض الحوض؟

A) Breathe slowly and deeply

يتنفّس ببطء وعمق

B) Take two deep breaths during exposure

يأخذ نفَسين عميقين أثناء التعرّض

C) Suspend respiration ✓ الجواب الصحيح

يوقف التنفّس

D) Breathe normally

يتنفّس بشكل طبيعي

💡 المحاضرة: أوقِف التنفّس أثناء التعرّض.

5.

Which three parts form each hip bone?

ما الأجزاء الثلاثة التي يتكوّن منها كل عظم ورك؟

A) Sacrum, coccyx and ilium

العجز والعصعص والحرقفة

B) Ilium, femur and pubis

الحرقفة وعظم الفخذ والعانة

C) Ilium, ischium and pubis ✓ الجواب الصحيح

الحرقفة والإسك والعانة

D) Ischium, sacrum and femur

الإسك والعجز وعظم الفخذ

رسم المحاضرة: (1) الحرقفة و(2) الإسك و(3) العانة.

6.

In the female pelvis, the angle of the pubic arch is:

في حوض الأنثى، زاوية القوس العاني تكون:

A) Less than 90° (acute)

أصغر من 90 درجة (حادّة)

B) Greater than 90° (obtuse) ✓ الجواب الصحيح

أكبر من 90 درجة (منفرجة)

C) Exactly 45°

45 درجة بالضبط

D) Exactly 90°

90 درجة بالضبط

صورة «الذكر مقابل الأنثى»: الأنثى > 90° (منفرجة)، والذكر < 90° (حادّة).

7.

Which part of the pelvis lies below the brim of the pelvis?

أيّ جزء من الحوض يقع تحت حافة الحوض؟

A) Greater or false pelvis

الحوض الكبير أو الكاذب

B) Lesser or true pelvis ✓ **الجواب الصحيح**

الحوض الصغير أو الحقيقي

C) Ala of the ilium

جناح الحرقفة

D) Iliac crest

العرف الحرقفي

💡 الرسم: الحوض الكبير (الكاذب) فوق حافة الحوض، والصغير (الحقيقي) تحتها.

8.

On the labelled AP pelvis, letter B (anterior end of crest) is:

في صورة الحوض المؤشّرة، الحرف B (النهاية الأمامية للعرف) هو:

A) Ischial tuberosity

الحدبة الإسكية

B) Greater trochanter

المدوَّر الكبير

C) ASIS ✓ **الجواب الصحيح**

الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية

D) Ischial spine

الشوكة الإسكية

💡 قائمة الصورة: الحرف B هو الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية ASIS (النهاية الأمامية للعرف).

9.

How is the hip joint classified?

كيف يُصنَّف مفصل الورك؟

A) Cartilaginous, synarthrodial

غضروفي، عديم الحركة

B) Cartilaginous, amphiarthrodial

غضروفي، قليل الحركة

C) Synovial, diarthrodial (ball and socket) ✓ الجواب الصحيح

زلالي، حرّ الحركة (كرة وتجويف)

D) Synovial, amphiarthrodial (limited)

زلالي، قليل الحركة (محدودة)

جدول مفاصل الحوض: مفصل الورك زلالي، حرّ الحركة، كروي (كرة وتجويف).

10.

Which pelvic joint is cartilaginous and nonmovable (synarthrodial) in adults?

أيّ مفاصل الحوض غضروفي وغير متحرّك عند البالغين؟

A) Union of acetabulum ✓ الجواب الصحيح

التحام الحُقّ

B) Sacroiliac joint

المفصل العجزي الحرقفي

C) Hip joint

مفصل الورك

D) Symphysis pubis

الارتفاق العاني

جدول مفاصل الحوض: التحام الحُقّ غضروفي، عديم الحركة عند البالغين، وغير متحرّك.

11.

For the AP pelvis, the feet and lower limbs are rotated internally by:

في إسقاط الحوض AP، يُدوَّر القدمان والطرفان السفليان إلى الداخل بمقدار:

A) 5°

5 درجات

B) 15° to 20° ✓ الجواب الصحيح

15 إلى 20 درجة

C) 40° to 45°

40 إلى 45 درجة

D) 30° to 35°

30 إلى 35 درجة

💡 وضعية الجزء: دوّر المحاور الطويلة للقدمين والطرفين للداخل 15° إلى 20°.

12.

Where is the CR directed for the AP pelvis?

إلى أين يُوجَّه الشعاع المركزي في إسقاط الحوض AP؟

A) Midway between ASIS and symphysis pubis ✓ الجواب الصحيح

منتصف المسافة بين ASIS والارتفاق العاني

B) To the level of the iliac crest

إلى مستوى العرف الحرقفي

C) 3 inches below the symphysis pubis

3 إنش أسفل الارتفاق العاني

D) To the level of the greater trochanters only

إلى مستوى المدوَّرين الكبيرين فقط

💡 الشعاع المركزي عمودي على IR، ويُوجَّه إلى منتصف المسافة بين ASIS والارتفاق العاني (نحو 5 سم أسفل ASIS).

13.

How is pelvic rotation checked in the AP pelvis?

كيف يُتأكّد من عدم دوران الحوض في إسقاط الحوض AP؟

A) Both knees are flexed 90°

ثني الركبتين 90 درجة

B) The feet are turned outward

تدوير القدمين للخارج

C) The CR is angled 15° cephalad

إمالة الشعاع 15 درجة باتجاه الرأس

D) Distance from tabletop to each ASIS is equal ✓ الجواب الصحيح

تساوي المسافة من سطح الطاولة إلى كل ASIS

💡 المحاضرة: يجب أن تتساوى المسافة من سطح الطاولة إلى كل ASIS.

14.

If a hip fracture or dislocation is suspected in the AP pelvis, the technologist should:

إذا شُكّ بكسر أو خلع في الورك في إسقاط الحوض AP، فعلى التقني أن:

A) Rotate the legs internally 30°

يدوّر الساقين للداخل 30 درجة

B) Not rotate the legs internally ✓ الجواب الصحيح

لا يدوّر الساقين إلى الداخل

C) Abduct the femora 45°

يُبعد عظمي الفخذ 45 درجة

D) Flex the knees 90°

يثني الركبتين 90 درجة

💡 التحذير: لا تحاول تدوير الساقين للداخل مع الشك بكسر أو خلع في الورك.

15.

The AP bilateral frog-leg projection is also called:

يُسمّى إسقاط ساق الضفدع AP للجانبين أيضاً:

A) Taylor method

طريقة تايلور

B) Judet method

طريقة جوديه

C) Danelius-Miller method

طريقة دانيليوس-ميلر

D) Modified Cleaves method ✓ الجواب الصحيح

طريقة كليفز المعدّلة

💡 عنوان الإسقاط الثاني في المحاضرة: ساق الضفدع، طريقة كليفز المعدّلة.

16.

In the frog-leg projection, the femora are abducted from vertical by:

في إسقاط ساق الضفدع، يُبعَد عظما الفخذ عن الخط العمودي بمقدار:

A) 15° to 20°

15 إلى 20 درجة

B) 40° to 45° ✓ الجواب الصحيح

40 إلى 45 درجة

C) 5° to 10°

5 إلى 10 درجات

D) 90°

90 درجة

💡 وضعية الجزء: أبعِد عظمي الفخذ 40° إلى 45° عن الخط العمودي، مع ثني الركبتين نحو 90°.

17.

Which clinical indication is listed for the frog-leg projection?

أيّ من دواعي الفحص التالية مذكور لإسقاط ساق الضفدع؟

A) Developmental dysplasia of hip (DDH)

الجواب الصحيح ✓

خلل التنسّج النمائي للورك DDH

B) Acetabular fracture in trauma

كسر الحُقّ في الإصابات

C) Posterior displacement of the pelvis

الإزاحة الخلفية للحوض

D) Pelvic inlet assessment

تقييم مدخل الحوض

💡 دواعي الفحص: ورك غير رضّي، وخلل التنسّج النمائي للورك (DDH).

18.

Where is the CR directed for the frog-leg projection?

إلى أين يُوجَّه الشعاع المركزي في إسقاط ساق الضفدع؟

A) At the level of ASIS

عند مستوى ASIS

B) 2 inches above the iliac crest

2 إنش فوق العرف الحرقفي

C) To the knee joints

إلى مفصلي الركبتين

D) 3 inches (7.5 cm) below level of ASIS

الجواب الصحيح ✓

3 إنش (7.5 سم) أسفل مستوى ASIS

💡 الشعاع المركزي عمودي ويُوجَّه إلى نقطة 3 إنش (7.5 سم) أسفل ASIS، أي 1 إنش (2.5 سم) فوق الارتفاق العاني.

19.

According to NOTE 2, abducting the femora only 20° to 30° gives:

حسب الملاحظة 2، إبعاد عظمي الفخذ 20 إلى 30 درجة فقط يعطي:

A) The least foreshortening of femoral necks

الجواب الصحيح ✓

أقل تقصير لعنقي عظمي الفخذ

B) The most foreshortening of femoral necks

أكبر تقصير لعنقي عظمي الفخذ

C) Better view of the sacrum

رؤية أفضل للعجز

D) Less radiation dose to the gonads

جرعة أقل للغدد التناسلية

💡 الملاحظة 2: إبعاد 20–30° يعطي أقل تقصير لعنقي الفخذ، لكنه يقصّر الجزء القريب من عظمي الفخذ كله.

20.

The AP axial outlet projection is also known as:

يُعرف الإسقاط المحوري لمخرج الحوض أيضاً بـ:

A) Taylor method

الجواب الصحيح ✓

طريقة تايلور

B) Judet method

طريقة جوديه

C) Modified Cleaves method

طريقة كليفز المعدّلة

D) Clements-Nakayama method

طريقة كليمنتس-ناكاياما

💡 عنوان الإسقاط الثالث في المحاضرة: مخرج الحوض، طريقة تايلور.

21.

For the outlet projection in females, the CR is angled cephalad:

في إسقاط مخرج الحوض للإناث، يُمال الشعاع المركزي باتجاه الرأس:

A) 20° to 35°

20 إلى 35 درجة

B) 40° caudad

40 درجة باتجاه القدمين

C) 30° to 45° ✓ الجواب الصحيح

30 إلى 45 درجة

D) 10° to 15°

10 إلى 15 درجة

💡 المحاضرة: 20–35° للذكور و30–45° للإناث، بسبب اختلاف شكل الحوض.

22.

Why are the CR angles different for males and females in the outlet projection?

لماذا تختلف زاوية الشعاع بين الذكور والإناث في إسقاط مخرج الحوض؟

A) Differences in the shape of male and female pelves ✓ الجواب الصحيح

اختلاف شكل حوض الذكر عن حوض الأنثى

B) Differences in the size of the IR

اختلاف حجم مستقبِل الصورة

C) Differences in gonadal shielding

اختلاف تدريع الغدد التناسلية

D) Differences in exposure factors

اختلاف عوامل التعرّض

💡 المحاضرة: هذه الزوايا المختلفة سببها اختلاف شكل حوض الذكر والأنثى.

23.

What does the outlet projection demonstrate well?

ماذا يُظهر إسقاط مخرج الحوض بوضوح؟

A) Superior and inferior pubic rami and body and ramus of ischium
فرعا العانة العلوي والسفلي وجسم الإسك وفرعه

الجواب الصحيح ✓

B) The pelvic ring (inlet) in its entirety
حلقة الحوض (المدخل) بكاملها

C) The posterior rim of the acetabulum
الحافة الخلفية للحُقّ

D) The lumbar spine
العمود القطني

💡 ما تُظهره الصورة: فرعا العانة وجسم الإسك وفرعه، بأقل تقصير أو تراكب.

24.

For the AP axial inlet projection, the CR is angled:

في الإسقاط المحوري لمدخل الحوض، يُمال الشعاع المركزي:

A) 40° cephalad
40 درجة باتجاه الرأس

B) 15° caudad
15 درجة باتجاه القدمين

C) Perpendicular, no angle
عمودياً بلا إمالة

D) 40° caudad
40 درجة باتجاه القدمين

الجواب الصحيح ✓

💡 الشعاع المركزي: أُمِلَه 40° باتجاه القدمين (قريباً من العمودي على مستوى المدخل).

25.

The inlet projection is used to assess pelvic trauma for:

يُستعمل إسقاط مدخل الحوض لتقييم إصابات الحوض من حيث:

A) Developmental dysplasia of hip

خلل التنسّج النمائي للورك

B) Degenerative disease of the hip

الأمراض التنكّسية للورك

C) Fracture of the femoral shaft

كسر جسم عظم الفخذ

D) Posterior displacement or rotation of the anterior pelvis ✓ الجواب الصحيح

الإزاحة الخلفية أو دوران الجزء الأمامي من الحوض

دواعي الفحص: الإزاحة الخلفية أو دوران الجزء الأمامي من الحوض للداخل أو الخارج.

26.

What does the AP axial inlet projection demonstrate?

ماذا يُظهر الإسقاط المحوري لمدخل الحوض؟

A) Only the femoral heads

رأسا عظمي الفخذ فقط

B) The anterior rim of the acetabulum only

الحافة الأمامية للحُقّ فقط

C) The coccyx only

العصعص فقط

D) The pelvic ring or inlet in its entirety ✓ الجواب الصحيح

حلقة الحوض أو مدخله بكامله

ما تُظهره الصورة: إسقاط محوري يُظهر حلقة الحوض أو مدخله (الفتحة العليا) بكامله.

27.

The posterior oblique pelvis–acetabulum projection is called:

يُسمّى الإسقاط المائل الخلفي للحوض والحُقّ:

A) Judet method

الجواب الصحيح ✓

طريقة جوديه

B) Taylor method

طريقة تايلور

C) Modified Cleaves method

طريقة كليفز المعدّلة

D) Lauenstein method

طريقة لاونشتاين

💡 عنوان الإسقاط الخامس في المحاضرة: المائل الخلفي للحُقّ، طريقة جوديه.

28.

In the Judet method, the patient is placed in a posterior oblique of:

في طريقة جوديه، يوضَع المريض بوضع مائل خلفي بزاوية:

A) 15°

15 درجة

B) 45°

الجواب الصحيح ✓

45 درجة

C) 30°

30 درجة

D) 60°

60 درجة

💡 وضعية الجزء: مائل خلفي 45°، والحوض والصدر 45° عن سطح الطاولة.

29.

When centered to the downside acetabulum (Judet), which structures are demonstrated?

عند التمركز على الحُقّ السفلي (جوديه)، ماذا يظهر؟

A) Posterior rim of acetabulum and anterior (iliopubic) column

الحافة الخلفية للحُقّ والعمود الأمامي (الحرقفي العاني)

B) Obturator foramen and pubic symphysis only

الثقبة السدّادية والارتفاق العاني فقط

C) Anterior rim of acetabulum and posterior (ilioischial) column ✓ الجواب الصحيح

الحافة الأمامية للحُقّ والعمود الخلفي (الحرقفي الإسكي)

D) Sacrum and coccyx

العجز والعصعص

💡 ما تُظهره الصورة: الحُقّ السفلي ← الحافة الأمامية والعمود الخلفي، ويظهر جناح الحرقفة جيداً.

30.

When the acetabulum of interest is upside (Judet), the CR is centered:

إذا كان الحُقّ المطلوب في الجانب العلوي (جوديه)، يُمركَز الشعاع:

A) 2 inches distal and 2 inches medial to downside ASIS

5 سم أسفل و5 سم إنسيّ ASIS السفلية

B) At the level of the iliac crest

عند مستوى العرف الحرقفي

C) 3 inches above the symphysis pubis

3 إنش فوق الارتفاق العاني

D) 2 inches (5 cm) directly distal to upside ASIS ✓ الجواب الصحيح

5 سم أسفل ASIS العلوية مباشرةً

💡 الشعاع المركزي: للجانب العلوي، عمودي ومُمركَز 2 إنش (5 سم) أسفل ASIS العلوية مباشرةً.